



Главная / Населению / Инфекционные и паразитарные заболевания /
Инфекции от А до Я / Бактериальная дизентерия (шигеллез)

БАКТЕРИАЛЬНАЯ ДИЗЕНТЕРИЯ (ШИГЕЛЛЕЗ)



Дизентерия распространена повсеместно, встречается не только в странах с низкой, но и с высокой санитарной культурой.

Что нужно знать об этом заболевании и как от него защититься? Рассказываем в нашей статье.

Бактериальная дизентерия (шигеллез) – острая инфекционная болезнь, вызываемая бактериями рода *Shigella* (шигелла) с фекально-оральным механизмом передачи возбудителя, характеризующаяся симптомами расстройства кишечника и интоксикацией.

Термин «дизентерия» (от греч. *dys* - нарушение, расстройство, *enteron* - кишка) появился еще в эпоху Гиппократ, который относил к дизентерии все кишечные заболевания, сопровождающиеся болями в животе. Первое подробное описание болезни под названием «натужный понос» дал греческий эскулап Аретей (1 в. до н.э.).

Заболевания, сходные по клинической картине с дизентерией, нашли отражение в трудах Авиценны (X-XI вв.). В древнерусской письменности описание этой болезни встречается под названием «утроба кровавая, или мыт».

Дизентерия в прошлом была широко распространена, носила характер эпидемий. Самые большие эпидемии наблюдались в периоды войн и стихийных бедствий.

Огромный вклад в изучение возбудителей дизентерии внесли русские ученые. В 1875 г. А.С. Раевский обнаружил бактерии в стенке кишечника человека, умершего от кровавого поноса, в 1889 г. П.И. Кубасов выделил «длинные бациллы» из испражнений и органов людей, умерших от дизентерии.

В 1891 году русский врач А.В. Григорьев выделил бактерии возбудителя дизентерии из органов умерших от этой болезни людей, изучил морфологию микроорганизмов и подробно их описал.



В 1898 г. японский ученый К. Шига о том же возбудителе дизентерии сообщил некоторые новые данные. В дальнейшем исследователи из разных стран открыли других представителей обширной группы дизентерийных бактерий. В честь них выделенные микроорганизмы и, соответственно, заболевания получили свои названия: дизентерия Григорьева-Шиги, дизентерия Флекснера, дизентерия Зонне и др.

Шигеллезы регистрируются повсеместно, но заболеваемость преобладает в развивающихся странах. Повышенная заболеваемость шигеллезами связана с низким уровнем медицинского обслуживания, необеспеченностью населения адекватным водоснабжением, питанием, санитарно-коммунальным обслуживанием. Для стран с умеренным климатом характерна летне-осенняя сезонность.

По данным Всемирной организации здравоохранения заболеваемость шигеллезами в мире превышает 100 млн случаев в год.

Реальное количество заболевших, несомненно, гораздо выше, поскольку значительная часть из них, в основном в развивающихся странах, за медицинской помощью не обращается.

В Российской Федерации в многолетней динамике отмечается тенденция к ежегодному снижению заболеваемости дизентерией. Однако в 2024 году заболеваемость (3,13 на 100 тыс. населения) в 1,8 раза превысила показатель 2023 года (1,76 на 100 тыс. населения), но почти в 2 раза была ниже среднего многолетнего показателя (5,74 на 100 тыс. населения).

Возбудители дизентерии – бактерии, которые относятся к роду *Shigella* семейства *Enterobacteriaceae*.

Шигеллы разделяют на 4 подгруппы (A, B, C, D) и, соответственно, на 4 вида: *S. dysenteriae*, *S. flexneri*, *S. boydii*, *S. sonnei*. Виды, в свою очередь, делятся на серовары: *S. dysenteriae* 1 (шигелла Григорьева-Шиги), *S. dysenteriae* 2 (шигелла Штутцера-Шмитца) и др. Всего насчитывают около 50 сероваров шигелл.

Наибольшее эпидемиологическое значение практически во всех странах мира, в том числе и в Российской Федерации, имеют *S. sonnei* и *S. flexneri*.

Устойчивость шигелл во внешней среде умеренная, зависит от вида возбудителя: например, *S. flexneri* и *S. sonnei* способны длительно сохраняться в воде. При кипячении шигеллы погибают мгновенно, в дезинфицирующих растворах – в течение нескольких минут.



Важная особенность *S. sonnei* – способность интенсивно размножаться в молоке и молочных продуктах.

Резервуаром и источником инфекции является человек (больной острой или хронической формой дизентерии, бактерионоситель).

Наибольшую опасность представляют больные и бактерионосители, которые по роду своей деятельности связаны с приготовлением пищи, хранением, транспортировкой и продажей пищевых продуктов.

Механизм заражения дизентерией – фекально-оральный, то есть бактерии из кишечника больного человека попадают в желудочно-кишечный тракт здорового человека.

Как это может произойти? Несколькими путями:

- **контактно-бытовым** – через загрязненные предметы, игрушки и грязные руки при несоблюдении правил личной гигиены;
- **пищевым** – при употреблении в пищу немытых овощей, фруктов и других продуктов питания, обсемененных бактериями. Здесь роль фактора передачи инфекции способны играть насекомые – мухи и тараканы, которые могут переносить на своих лапках возбудителя заболевания.
- **водным** – при попадании бактерий в организм человека через инфицированную воду, причем необязательно пить такую воду, достаточно в ней искупаться. Основные причины загрязнения воды – аварии на водопроводно-канализационных сетях, недостаточные меры по очистке воды и природные катаклизмы, например, паводки и ливневые дожди.

При водном пути передачи инфекции наблюдается самый высокий уровень заболеваемости с одновременным возникновением нескольких очагов.

Входными воротами инфекции является желудочно-кишечный тракт. В течение суток (иногда дольше) шигеллы находятся в желудке, затем попадают в тонкую кишку. При благоприятном течении болезни через 1–3 дня тонкая кишка освобождается от бактерий, патологический процесс локализуется в толстой кишке. Попав в толстую кишку, шигеллы начинают интенсивно размножаться, приводя к развитию характерных для дизентерии симптомов – диареи с примесями слизи и крови, схваткообразных болей в животе, тенезмов (ложных болезненных позывов к дефекации).

Продолжительность инкубационного периода – от 1 до 7 дней (чаще 2–3 дня).



В зависимости от длительности болезни, дизентерию подразделяют на острую (продолжительность от нескольких дней до 3 месяцев) и хроническую (свыше 3 месяцев).

По тяжести течения – на легкую, средней степени тяжести и тяжелую формы. По клиническим проявлениям – на колитический, гастроэнтероколитический и гастроэнтеритический варианты.

Отдельной формой дизентерии является бактериовыделение (бактерионосительство), которое рассматривается как субклиническая (то есть не имеющая симптомов) форма инфекционного процесса.

Бактерионоситель, практически не имея симптомов, опасен для окружающих, поскольку является источником возбудителя инфекции.

Лечение больных дизентерией может осуществляться не только в условиях специализированного инфекционного отделения, но и амбулаторно. Необходимость госпитализации определяется клиническими (тяжелое или среднетяжелое течение болезни, наличие выраженных сопутствующих заболеваний) и эпидемиологическими (принадлежность к декретированной группе) показаниями.

Прогноз при своевременном и полноценном лечении дизентерии благоприятный. Осложнения встречаются редко. К ним относятся инфекционно-токсический шок, перфорации кишечника, перитонит и др.

В некоторых случаях после клинического выздоровления возможно формирование реконвалесцентного бактерионосительства, которое сопровождается выделением шигелл в течение 1-3 месяцев, а иногда и дольше.

В результате перенесенной дизентерии возникает нестойкий типоспецифический иммунитет, что обуславливает возможность повторных заболеваний.

В отношении шигеллеза, вызываемого *S. sonnei*, разработаны меры специфической профилактики (вакцинация). В результате вакцинации формируется иммунитет, обеспечивающий невосприимчивость к инфекции в течение 1 года; при необходимости ежегодно проводится ревакцинация.

Вакцинации подлежат работники медицинских организаций инфекционного профиля; лица, занятые в сфере общественного питания и коммунального благоустройства; дети, посещающие дошкольные образовательные организации и выезжающие в организации, осуществляющие лечение, оздоровление, отдых (по показаниям). По эпидемическим показаниям прививки проводятся при угрозе возникновения эпидемии или вспышки шигеллезов (стихийные бедствия, крупные аварии на водопроводной и канализационной сети), а также в период эпидемии, при этом в угрожаемом регионе проводят массовую вакцинацию населения.

Профилактические прививки предпочтительно проводить перед сезонным подъемом заболеваемости шигеллезами.

В настоящее время ведется разработка вакцин против дизентерии, вызванной не только *S. sonnei*, но и другими шигеллами. Цель такой работы – получение поливалентной вакцины, способной защитить от максимального количества наиболее распространенных шигеллезов.

Меры неспецифической профилактики при дизентерии направлены на предотвращение передачи возбудителя с пищей, водой, грязными руками.

Для профилактики заражения дизентерией необходимо:

- Соблюдать правила личной гигиены – обязательно мыть руки с мылом или использовать антисептик на спиртовой основе перед приготовлением, приемом пищи и после посещения туалета.
- Соблюдать чистоту на кухне, рекомендации по условиям и срокам хранения продуктов в холодильнике, не допускать проникновения насекомых в дом – мух и тараканов.
- Овощи и фрукты тщательно мыть перед употреблением, затем обдавать кипятком. Сырую пищу при приготовлении подвергать тщательной термической обработке.
- Не приобретать и не употреблять пищу с истекшим сроком годности.

- Не покупать продукты в местах несанкционированной торговли и “с рук”, особенно сметану, молоко, творог.
- Не пить воду из источников, не предназначенных для питьевых целей – озера, реки, ключи, колодцы. Пить только кипяченую или бутилированную воду.
- Купаться только в разрешенных для этого водоемах, не заглатывать воду при нырянии.

В случае появления симптомов заболевания не занимайтесь самолечением, а обратитесь за медицинской помощью!

Использованные материалы:

1. *Инфекции с диарейным синдромом у туристов и мигрантов (медицина путешествий): в 5 ч. Ч.2. Общая характеристика диарейных заболеваний. Дизентерия. Эшерихиозы. Холера. Брюшной тиф и другие сальмонеллезы. Кампилобактериоз* / В. В. Нечаев, В. А. Неверов, Г. И. Гришанова ; под ред. Ю. В. Лобзина. – Санкт-Петербург : СпецЛит, 2016. – 143 с.
2. *Инфекционные болезни : национальное руководство* / под ред. Н. Д. Ющука, Ю. Я. Венгерова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 1104 с. - (Серия «Национальные руководства»).
3. *О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2024 году: Государственный доклад*. М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2025. 424 с.
4. *Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 N 1122н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок"*
5. *Руководство по эпидемиологии инфекционных болезней [в 2 т.]. Т. 1* / Н.И. Брико, Г.Г. Онищенко, В.И. Покровский. - Москва : ООО «Издательство «Медицинское информационное агентство», 2019. - 880 с. : ил.

Источник изображения: Freepik.

(<https://yandex.ru/>)

О центре (/about/)

Населению (/naseleniyu/)

Коллегам (/kollegam/)

Контакты

Адрес: 121099, г. Москва, 1-й Смоленский переулок, дом 9, стр.1

Телефон: 8 (499) 241 86 28 (tel:+74992418628)

Бухгалтерия: 8(499) 241 87 50
(tel:+74992418750)

Бизнесу (/biznesu/)

Отгрузка ЛМК: 8 (499) 241 00 70
(tel:+74992410070)

История (/istoriya/)

Договора: 8 (499) 241 85 45 (tel:+74992418545)

ЛМК (/lichnye-meditsinskie-
knizhki/)

Эл. почта: cgon@cgon.ru (mailto:cgon@cgon.ru)

Сайт: <https://cgon.rospotrebnadzor.ru/>
(<https://cgon.rospotrebnadzor.ru/>)

БАДы (/bady/)

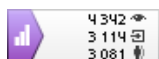
Дополнительно
(/dopolnitelno/)



16+

ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения» Роспотребнадзора

Политика обработки персональных данных (/privacy)



(<https://metrika.yandex.ru/stat/?id=38754610&from=informer>)